

TEMA 5.10 • OFTALMOLOGÍA

pérdida súbita de visión

PERFIL EUNACOM 6.02.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trastornos Causantes de Pérdida Visual Lenta

- Existen tres patologías primordiales que caracterizan la enorme mayoría de consultas de ceguera o pérdida de visión paulatina e **indolora** en la población adulta superior, cada una con etiologías, exámenes confirmatorios y pronósticos muy diferenciados:
- Cataratas:** Primera causa de ceguera general (absolutamente tratable/reversible).
- Glaucoma Crónico:** Segunda causa de ceguera a nivel global (daño permanente que solo se puede frenar).
- Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE):** Principal causa de ceguera central adquirida; tratamientos poco eficaces a largo plazo.

1. Cataratas

Corresponde a la claudicación visual por opacificación paulatina del cristalino. Es la etiología y causa evitable de ceguera más frecuente.

- Patrón Clínico:**
 - Pérdida de agudeza visual muy lenta y progresiva y de base **indolora**.
 - "Encandilamiento" / Glare:** El paciente refiere enorme fastidio y reducción de la agudeza en ambientes extremadamente luminosos o por reflejos directos.
 - Alteración de refracción paradójica:** Muchos reportan poder ver su lectura de letras pequeñas mucho mejor, en detrimento de la visión de lejos (una falsa corrección de la presbicia natural pre-existente).
- Inspección Física (Signos de Alarma Clásicos):**
 - Disminución abrumadora, alteración o pérdida del **Rojo Pupilar** a la oftalmoscopia.
 - Leucocoria:** Al iluminarse tangencialmente el ojo o directo, la pupila se evidencia llanamente blanca y opacificada.
- Causas/Factores de Riesgo:**
 - Ocurrencia aplastante de la Variante Senil (edad avanzada fisiológica).
 - Factores perjudiciales modificables: Tabaquismo, abuso de alcohol crónico, pobreza limitante, y severa radiación de los rayos UV sin lentes de sol.
 - Inducción secundaria sistémica: Uso masivo de **corticoides** prolongados y en pacientes con **Diabetes Mellitus**.
- Tratamiento:** El abordaje final curativo es meramente quirúrgico precoz: **Facoemulsificación** (Facoectomía de extracción del cristalino en bloque) más implante in situ de un **Lente Intraocular (LIO)**. (Procedimiento inserto bajo el esquema de garantías GES en Chile frente a ceguera impeditiva).

2. Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE)

Afectación degenerativa macular idiopática fuertemente gatillada por edad avanzada y **tabaquismo activo**.

- Clínica Clásica:** Adulto mayor con lenta pérdida gradual de su **visión central fina**. No acusa inflamación anatómica exterior y la inspección general y reflejos están normales frente a lo que acontece en una catarata.
- Signo cardinal:** Presencia frecuente de **Metamorfopsias**. El paciente expresa ver las líneas y márgenes rectos sumamente deformados, y letras fuertemente onduladas (*No confundir con los clásicos flotadores normales en humor vítreo = miodesopsias*).
- Variantes y Fondo de Ojo Clínico:**
 - 1. Maculopatía de Tipo Seca (Más frecuente, >85%)**
 - Ocurre progresión a lo largo de bastantes años.

- Focaliza aparición visible de **Drusas** (pequeñas manchitas y material de desecho de lípidos estables reticulares) localizados bajo el epitelio macular.
- 2. Maculopatía de Tipo Húmeda (Severa y rara)**
 - Evolución subintrante mucho más rápida que corrompe la mácula en corto lapso de semanas-meses.
 - Presencia patológica de proliferación de densos **exudados serosos e incluso Exudados Hemorrágicos** evidentes sobre la cicatriz isquémica neovascular central.
- Examen Auxiliar Diagnóstico:** La prueba insigne e inmensamente preferida en la patología macular y retina microscópica es la **Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)**. Resulta excelente objetivando alteraciones degenerativas y de fluidos.
- Tratamiento Limitado:**
 - Tipo Seca:** Modificación paliativa de riesgo (Supresión del tabaco estricta) y adición eventual de formulaciones ricas en vitaminas antioxidantes complejas y Vitamina B, con el objeto exclusivo de dilatar progresión.
 - Tipo Húmeda:** Agencias antiangiogénicas intraoculares (Anti-VEGF) acompañados muchas veces por **fotocoagulación láser** sellando ramificaciones neovasculares frágiles e insolentes que continúan exudando hematomas localizados.

3. Glaucoma Crónico (De ángulo abierto)

Cronicidad degenerativa silenciosa dada un defecto en el trabeculado y balance hidrodinámico entre el ingreso y reabsorción del humor acuoso.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Dato Fisiopatológico Clínico de EUNACOM: Recuerda encarecidamente que el Glaucoma Crónico en general es una **Neuropatía Óptica crónica estructural**, secundaria a estrés del nervio a veces por hipertensión. La hipertensión ocular en estricto rigor **No es sinónimo inmediato y definitorio** a Glaucoma si no existe daño patológico en la excavación del nervio y campimetría final anatómica concomitante.

- Clínica Traicionera (El ladrón furtivo visual):**
 - Curso asintomático inicial y centralmente la **Agudeza Visual siempre está normal y preservada hasta estadios terminales irreversibles**. El examinado lee la Tabla de Snellen perfectamente.
 - Pérdida concéntrica y circunferencial del campo visual periférico (Aparición de escotomas silenciosos).** Acaba derivando inevitablemente en una trágica tardía "visión tubular o en cañón" a manera de túnel final, si no se interceptó.
- Diagnóstico Integral Triádico (Screening y Confirmación):**
 - 1. Tonometría Ocular (Mide PIO):** El screening de base. Un valor normal límite tolerado es **hasta 20 mmHg**.
 - 2. Campimetría:** Fundamental frente a una PIO sospechosa. Examen confirmatorio biológico para registrar patología funcional al evidenciar el daño y estrechamiento campimétrico incuestionable.
 - 3. Fondo de Ojo / Papiloscopía:** Inspeccionar la emergencia propia estructural de salida del nervio por el disco u papila. Registra **Aumento de la excavación de la papila óptica** (cuando la tasa área excavación de la copa ocupa abrumadoramente el remanente en disco, mayor a un tercio anatómico, deprimido por necrosis compresiva).

Herramientas de Primera Línea en el Control Glaucomatoso

- Tratamiento Farmacológico (Sino se va la cirugía láser trabecular):**
 - Se manejan típicamente a través de prolongados colirios hipotensores hipotensores, como base estándar vitalicia en gota oftálmica:

- **Latanoprost (Análogos de prostaglandinas):** Esfuerzo de recomendación líder y oro como primera línea internacional sostenido. Aumenta drenaje uveoscleral, eficaz control pero un efecto cosméticamente conocido de engrosamiento paradójico masivo de las largas pestañas locales.
- **Timolol (Betabloqueador tópico):** De empleo muy tradicional también. Precaución severa médica porque su absorción se esparce sistémica: **Absolutamente contraindicados históricamente en crisis asmáticas y en cuadros EPOC broncoconstrictores severos por reacción letal.**
- **Pilocarpina (Agonistas colinérgicos)**

NOTA CLÍNICA

Nota Farmacológica Práctica Terapia farmacológica sistémica comórbida en un paciente añoso: Evita recetar antidepresivos sistémicos y Fármacos Anticolinérgicos potentes como Ciertos tricíclicos (Ej. **Amitriptilina**) sin consulta médica oftalmológica. Los efectos de dilatadores sistémicos están fuertemente contraindicados en pacientes de edad con ojo propenso a presiones limitantes elevadas y obstrucciones reticulares latentes crónicas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de cincuenta y cinco años con diabetes mellitus tipo dos de larga data consulta por pérdida visual aguda del ojo derecho. Refiere que todo se puso negro bruscamente. Al examen el reflejo rojo está ausente en ese ojo y no es posible visualizar el fondo de ojo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para pérdida súbita de visión. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El desprendimiento de retina se precede de fotopsias y entopsias seguidas de un velo o cortina que avanza cubriendo el campo visual.
- La oclusión de la vena central de la retina produce pérdida visual nunca completa con fondo de ojo en pizza: hemorragias en los cuatro cuadrantes.
- La oclusión de la arteria central de la retina produce pérdida visual completa y súbita, con retina pálida y mancha rojo cereza en la fovea.
- La hemorragia vítrea se caracteriza por alteración o pérdida del reflejo rojo; la causa más frecuente es retinopatía diabética proliferativa.
- La neuritis óptica produce pérdida visual subaguda, tiene defecto pupilar aferente y se asocia a esclerosis múltiple; tratamiento con metilprednisolona intravenosa.
- La neuropatía óptica isquémica es la causa más frecuente de pérdida visual aguda en mayores de cincuenta años y se asocia a arteritis de la temporal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN)

PREGUNTA 1

Un hombre de cincuenta y cinco años con diabetes mellitus tipo dos de larga data consulta por pérdida visual aguda del ojo derecho. Refiere que todo se puso negro bruscamente. Al examen el reflejo rojo está ausente en ese ojo y no es posible visualizar el fondo de ojo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Oclusión de la arteria central de la retina
- B) Hemorragia vítrea
- C) Neuritis óptica
- D) Desprendimiento de retina
- E) Glaucoma agudo de ángulo cerrado

PREGUNTA 2

Una mujer de veintiocho años consulta por pérdida visual del ojo izquierdo de dos días de evolución, que describe como progresiva y con algo de dolor al mover el ojo. Tiene un defecto pupilar aferente ipsilateral. Hace seis meses tuvo un episodio de parestesias en la mano derecha que se resolvió solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A) Oclusión de la arteria central de la retina; tratamiento con trombolisis
- B) Neuritis óptica; tratamiento con metilprednisolona intravenosa
- C) Desprendimiento de retina; tratamiento quirúrgico urgente
- D) Neuropatía óptica isquémica; tratamiento con corticoides
- E) Hemorragia vítrea; tratamiento con observación y control

PREGUNTA 3

Un paciente de setenta años consulta por pérdida visual brusca y completa del ojo derecho de una hora de evolución. No refiere dolor. Al fondo de ojo se observa retina pálida con una mancha rojo cereza en la fovea. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la causa más frecuente de este cuadro?

- A) Oclusión de la vena central de la retina; causa más frecuente es hipertensión arterial
- B) Oclusión de la arteria central de la retina; causa más frecuente es embolia
- C) Hemorragia vítrea; causa más frecuente es retinopatía diabética
- D) Neuritis óptica; causa más frecuente es esclerosis múltiple
- E) Desprendimiento de retina; causa más frecuente es la miopía alta

RESUMEN: PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN

La pérdida súbita de visión es una emergencia oftalmológica que puede tener múltiples etiologías, cada una con características clínicas y hallazgos específicos que permiten orientar el diagnóstico. Las principales causas son: desprendimiento de retina, oclusión de la vena central de la retina, oclusión de la arteria central de la retina, hemorragia vítrea, neuritis óptica y neuropatía óptica isquémica. El desprendimiento de retina se precede clásicamente por fotopsias, que son destellos luminosos, y entopsias, que son manchas o moscas volantes. Luego el paciente nota un velo o cortina que avanza desde un lado cubriendo progresivamente el campo visual. El tratamiento es quirúrgico urgente. La oclusión de la vena central de la retina produce una pérdida visual aguda nunca completa, con el característico fondo de ojo en pizza o pizza retina, con hemorragias en los cuatro cuadrantes retinianos. La oclusión de la arteria central de la retina produce una pérdida visual completa y súbita, con mancha rojo cereza en la fovea y retina pálida edematosa. Es la emergencia isquémica más grave del ojo y puede requerir trombolisis. La hemorragia vítrea se caracteriza por la alteración o pérdida del reflejo rojo, que es su hallazgo más característico. La causa más frecuente es la retinopatía diabética proliferativa. La neuritis óptica produce pérdida visual subaguda de horas a días, se asocia a esclerosis múltiple y tiene defecto pupilar aferente. El tratamiento es metilprednisolona intravenosa. La neuropatía óptica isquémica es la causa más frecuente de pérdida visual aguda en mayores de cincuenta años y se asocia fuertemente a arteritis de la temporal.